Schock ist nicht gleich Schock – vergleichen und nach Leitsymptom handeln

🎯 **Lernziel:** Die Lernenden vergleichen die drei Schockformen und begründen Sofortmaßnahmen und Lagerung anhand des Leitsymptoms. Sie grenzen eigenverantwortliche von ärztlich angeordneten Maßnahmen ab und korrigieren typische Fehlvorstellungen (Schocklage bei Atemnot, Antihistaminikum statt Adrenalin).

Rahmen: KB I · Woche 2 (SW 7) · 3 UE (135 min) · Leitfall „Frau Maler“ (11 Uhr, Kausalkette) · Vorwissen: Woche 1 (Kompensation, Schockspirale, Schockindex), Erste-Hilfe-Kurs und Positionierung (1. AJ), Thromboseprophylaxe (1. AJ), PESR (1. AJ) · Ich-kann-Liste KB I, Woche 2, Nr. 1–5 · KA-Bezug: KB 1, Aufg. 3.1–3.3 und 5.5

Kompetenzbezug: Anlage 1 PflAPrV I.1.d, I.4.a, I.4.c, III.2.b · Landeslehrplan CE 06 „In Akutsituationen sicher handeln“ (1./2. AD: „Sofortmaßnahmen bei Schockzuständen“, „Verabreichung von Notfallmedikamenten nach ärztlicher Anordnung“, „Sofortmaßnahmen bei Verdacht auf … Lungenembolie“, Simulation von Notfallsituationen)

Zeit	Phase	Lehrerhandeln	Schülerhandeln	Sozialform	Material	Didaktische Funktion
vor der Stunde	**Vorbereitung**	Yogamatten auslegen; 3 Schilder in die Raumecken (Anlage); **Tischkarten** mit Emoji auf die Gruppentische (KB1_W2_Tischkarten.pdf, so viele wie Stammgruppen); wenige Expertenblätter A/B/C ans Pult; **beamer.html** öffnen → „Neuen Raum starten“.	–	–	Matten, Schilder, Tischkarten, Beamer	Ablauf ohne Umbaupausen
0–8	**Problemorientierter Einstieg: „Wie hätten Sie gehandelt?“ (Folien 1–6)**	**Folie 1:** QR-Code am Beamer, die Namen der Angemeldeten erscheinen. **Folie 2:** Fallauszug und Leitfrage; Vermutung aus W1 (AA3a) kurz abrufen. **Folie 3:** Abstimmung freigeben: „Falsch liegen ist erlaubt.“ **Folie 4:** Ergebnis (★ = größte Uneinigkeit, Karte anklicken = groß). **Folie 5:** Murmeln – die Uhr (1 min) startet automatisch; 2–3 Begründungen hören, nicht auflösen. **Folie 6:** Lernziel und Fahrplan.	Mit Vornamen anmelden; Vermutungen am Handy abgeben (sicher / vermute nur), auch zur Leitfrage (E6); die Nachbarin oder den Nachbarn von der eigenen Wahl überzeugen.	EA → PA (Murmeln) → Plenum	Beamer, Handy, AB S. 1	Vorwissen aktivieren, Vermutungen bilden, Fehlvorstellungen sichtbar machen (IKL Nr. 4); kognitiver Konflikt; die Vermutungen werden im Check-out überprüft (vorher/nachher). AFB I

„Bei E… sind Sie geteilter Meinung – genau das klären wir heute. In Woche 1 haben Sie gesehen, wie der Körper einen Schock ausgleicht. Heute geht es um die Frage: Ist jeder Schock gleich – und muss ich deshalb immer gleich handeln? Am Ende der Stunde prüfen Sie Ihre Vermutungen.“

Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau – Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock 2 - Thema: Schock	

Zeit	Phase	Lehrerhandeln	Schülerhandeln	Sozialform	Material	Didaktische Funktion
8–23	**Erarbeitung I: Expertenteams (AA1, Folien 7–8)**	**Folie 7:** Ablauf zeigen; Personen ohne Handy mit „+ Person ohne Handy“ eintragen; **„Gruppen zufällig einteilen“** (Name anklicken = in die nächste Gruppe). **Folie 8:** Uhr starten; die Teams finden sich über die Namen am Handy; Status je Team am Beamer. Sind alle Teams fertig, wechseln Beamer und Handys **automatisch** zu Folie 9.	Im Expertenteam: Fall am Handy markieren, Infotext lesen, die eigene Spalte der Vergleichstabelle ausfüllen, Klausuraufgabe 1.1 (Wortlaut KA 3.1), Experten-Check, „Unsere Spalte ist fertig“.	GA (Expertenteam 3–4)	Handy, AB S. 2–3, Expertenblätter (freiwillig)	Befunde im Fließtext identifizieren wie in KA 3.1; Expertenwissen aufbauen; der Experten-Check sichert, dass jede Person erklären kann. AFB I–II
23–43	**Erarbeitung II: Stammgruppe (AA2, Folien 9–11)**	**Folie 9:** „Umsetzen!“ – die Handys zeigen Stammgruppe, Namen und Tischkarte; **Erklär-Uhr** starten (A → B → C je 3 min, Ton beim Wechsel, dazu 2 min Gemeinsamkeit); Status je Gruppe. **Folie 10:** Detektiv, Fortschritt je Stammgruppe. **Folie 11:** Klausurtraining 2.1/2.2 mit Uhr, Expertenkorrektur.	Reihum erklären, die Spalten der anderen ausfüllen, „Unsere Tabelle ist vollständig“; Schockform-Detektiv, Merksatz; 2.1 und 2.2 schreiben, Expertenkorrektur.	GA (Stammgruppe 3–4)	AB S. 2–4, Handy, Tischkarten	Vergleichen (IKL Nr. 1); Pathophysiologie erläutern (KA 3.2), Unterschied neurogen (KA 5.5). AFB II
„Sie wissen jetzt, wie sich die Schockformen unterscheiden. Aber wie lagern Sie? Aus dem Erste-Hilfe-Kurs kennen Sie: ‚Beine hoch.‘ Prüfen wir, ob das immer stimmt.“						
43–63	**Erarbeitung III: Lagerungsparcours (AA3, Folien 12–13)**	**Folie 12:** Impuls „Bei einem Schock immer Beine hoch?“. **Folie 13:** Paare bilden, eine Karte gemeinsam vormachen (Ablauf, Sicherheit); Fortschritt am Beamer; Entscheidungsweg kurz sichern.	Karten am Handy ziehen, lagern und begründen, aufdecken, Rollen tauschen; Merksatz; Entscheidungsweg; 3.1 und 3.2.	PA → EA	Yogamatten, Kissen, Handy, AB S. 4–5	Handlungsorientiert; Fehlvorstellung „immer Beine hoch“ korrigieren; Lagerungsbegründung als K.-o.-Kriterium in KA 3.3. AFB II
63–88	**Erarbeitung IV: Notfall-Simulation (AA4, Folien 14–15)**	**Folie 14:** Rollen erklären, Start gemeinsam, Rollenwechsel einfordern; Fortschritt je Stammgruppe; Plenum: Warum unterschiedliche Lagerung? **Folie 15:** Pause mit Uhr (bei Bedarf überspringen).	Drei Varianten spielen (die Handys zeigen die Stammgruppe), protokollieren, Zeitstrahl mit Protokoll vergleichen; 4b und 4.1 beantworten.	GA (Stammgruppe 3–4) → Plenum	Handy (1 je Gruppe), Notfallprotokoll (Anlage)	Sofortmaßnahmen in Entscheidungen umsetzen (I.4.a); Dokumentation; 4.1 übt die KA-Punkte „Infusion stoppen, Zugang belassen“, „Adrenalin/Sauerstoff nach SOP“ schriftlich (KA 3.3). AFB II
Pause (falls im Stundenraster vorgesehen). – „In der Simulation mussten Sie entscheiden: Darf ich das – oder brauche ich eine Anordnung?“						

Zeit	Phase	Lehrerhandeln	Schülerhandeln	Sozialform	Material	Didaktische Funktion
88–100	**Vertiefung: Wer darf was? (AA5, Folien 16–17)**	**Folie 16:** Jeder Klick deckt die nächste Maßnahme auf, der nächste zeigt die Lösung (8 Maßnahmen); bei Uneinigkeit nachfragen. **Folie 17:** Dialog, Think-Pair-Share mit Uhr.	In die passende Ecke gehen und begründen, Tabelle ausfüllen; Stellungnahme zu Herrn Brandt schreiben.	Plenum (Bewegung) → EA → PA	Schilder, AB S. 6–7	Verantwortungsgrenzen (III.2.b); Fehlvorstellung Antihistaminikum (IKL Nr. 3–4). AFB II–III
„Jetzt wie in der Klassenarbeit: allein, ohne Unterlagen, mit Punkten."						
100–115	**Sicherung: Klausurtraining (AA6, Folien 18–19)**	**Folie 18:** Countdown 8 min. **Folie 19:** Tauschpartnerin oder Tauschpartner aus einer anderen Stammgruppe; das Raster erscheint am Handy; Rückmeldesatz einfordern.	Transferfall lösen; Lösung der Partnerin oder des Partners mit dem App-Raster bewerten.	EA → PA	AB S. 7–8, Handy	Transfer auf einen neuen Fall wie in der KA (3.3); Examensformat. AFB III
115–130	**Transfer: Zurück zu Frau Maler (AA7, Folien 20–21)**	**Folie 20:** Placemats austeilen, Uhr mit 3/3/4 min. **Folie 21:** Die Kausalkette Schritt für Schritt aufdecken, dann die Antwort auf die Leitfrage; eine Gruppe stellt vor.	Placemat bearbeiten, Kausalkette in der Mitte, Leitfrage beantworten; 7.1/7.2 beginnen.	GA (4) → Plenum	Placemat A3	Kausalkette (IKL Nr. 5); offene Frage aus W1 klären; Brücke zu W4 und W7. AFB III
130–135	**Abschlusssicherung: „Hätten Sie richtig gehandelt?" (Folien 22–25)**	**Folie 22:** Check-out-Abstimmung. **Folie 23:** Vermutung (Beginn) und Entscheidung (Ende) mit Lösung; größte Veränderung besprechen (v. a. E6 = Leitfrage). **Folie 24:** Ich-kann-Liste, Hausaufgabe. **Folie 25:** Ausblick – damit wird die Nachlese-Seite freigeschaltet.	Dieselben Fragen erneut entscheiden, Auflösung mit der eigenen Vermutung vergleichen; Ich-kann-Liste (Ampel); Leitfrage beantworten.	EA → Plenum	Handy, Beamer, Ich-kann-Liste	Vermutungen überprüfen, Lernzuwachs sichtbar machen (vorher/nachher); Lernstandsdiagnose.
„Nächste Woche geht es darum, wie man eine starke Blutung stoppt – damit es gar nicht erst zum hypovolämischen Schock kommt."						

Vorbereitung und Hinweise

Gruppeneinteilung

- **Per Knopfdruck am Beamer (Folie 7):** Stammgruppen zu 3 (A, B, C); geht es nicht auf, Vierergruppen mit doppeltem B (Anaphylaxie ist Klausurschwerpunkt). Expertenteams zu 3, Rest zu 4; zwei B-Expertinnen derselben Stammgruppe kommen in verschiedene Teams. Wer später kommt, wird automatisch eingeteilt; Personen ohne Handy trägt die Lehrkraft vorher mit „+ Person ohne Handy" ein.

- **3BFP2.1 (23 SuS):** 7 Stammgruppen (5 × 3, 2 × 4) · Expertenteams A1–A2, B1–B3, C1–C2 · Lagerungsparcours: 10 Paare + 1 Dreiergruppe (11 Matten) · Placemat: 5 Vierergruppen + 1 Dreiergruppe. **3BFP2.2 (20 SuS):** 6 Stammgruppen (4 × 3, 2 × 4) · Expertenteams A1–A2, B1–B2, C1–C2 · 10 Paare (10 Matten) · Placemat: 5 Vierergruppen.
- Die Simulation (AA4) läuft in den Stammgruppen; in Vierergruppen übernimmt die vierte Person die Beobachtung (Lagerung, Verantwortung) und gibt nach jeder Runde einen Hinweis.

Material und Technik

- Kopien: AB (SV) für alle; Expertenblätter A/B/C nur zum Auslegen am Pult (freiwillig, z. B. je 3); Notfallprotokoll 1 je Stammgruppe; Placemat auf A3 (1 je Vierergruppe); drei Schilder für die Raumecken; **Tischkarten** (KB1_W2_Tischkarten.pdf) – quer drucken, in der Mitte falten. Yogamatten, einige Kissen/Decken als Polster.
- **Beamer: beamer.html** öffnen → „Neuen Raum starten“. Unten rechts **Weiter**, links **Zurück** (auch Pfeiltasten, Presenter); Menü ⚙ unten links: zu jeder Folie springen, Vollbild, Namen verbergen, Angemeldete verwalten, neuer Raum für die Parallelklasse. Die Handys wechseln automatisch mit; ein QR-Code unten auf jeder Folie lässt Nachzügler einsteigen. Probeansicht ohne Internet: beamer.html?demo=1.
- **Nachlese-Seite** (QR-Code auf der letzten AB-Seite): alle Inhalte und Lösungen der Stunde zum Wiederholen. Sie ist gesperrt, solange irgendwo eine Beamer-Stunde läuft – bis Folie 25 erreicht ist oder 10 Minuten nach dem Schließen des Beamers.
- Ohne WLAN oder Handys: Abstimmung per Handzeichen/Ampelkarten; Lagerungskarten aus der Liste unten vorlesen; Simulation als Fallkarte – die Lehrkraft spielt „Monitor“ und nennt die Werte nach den Entscheidungen der Gruppe (Drehbuch unten).
- Schutz gegen Durchklicken wie gewohnt: Merksätze erscheinen nur, wenn genug Aufgaben beim ersten Versuch richtig sind.

Inhaltliche Hinweise

- **Einstieg und Check-out („Wie hätten Sie gehandelt?“):** Zu Beginn geben die SuS Vermutungen ab – falsch liegen ist ausdrücklich erlaubt, die Sicherheit („sicher“ / „vermute nur“) macht Fehlvorstellungen sichtbar, die mit Überzeugung vertreten werden. Beim Einstieg nichts auflösen, auch nicht beim Murmeln. Im Check-out entscheiden die SuS dieselben sechs Fragen erneut und sehen danach die Auflösung neben ihrer Vermutung. E6 ist die Leitfrage (Frau Maler um 11 Uhr); sie wird in AA7 geklärt.
- Die Lagerungsempfehlungen folgen der S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021): symptomorientiert; Flachlagerung und Vermeiden abrupter Lageveränderungen (Aufsitzen, Aufstehen) als Grundstrategie; bei führender Atemnot (halb-)sitzend; bei eingeschränktem Bewusstsein und intaktem Kreislauf stabile Seitenlage; zur Kreislaufverbesserung Beine hoch.
- Adrenalin i. m. laut Leitlinie 0,15–0,6 mg in die Außenseite des Oberschenkels, Autoinjektoren 0,15/0,3/0,5 mg, Wiederholung nach ca. 5–10 min. Antihistaminika: langsamerer Wirkungseintritt, Wirkung auf Kreislauf und Bronchokonstriktion nicht belegt, lebensrettende Sofortmaßnahmen dürfen nicht verzögert werden. Glukokortikoide: untergeordnete Rolle in der Akutphase. Die KA-Lösung nennt „Erwachsene 0,5 mg“ – das liegt in diesem Bereich.
- Der Leitfall ist belastend (Christin, Reanimation). AA7 bleibt bewusst fachlich (Kausalkette, verpasste Chancen) und bewertet Christin nicht; Erleben, Hilflosigkeit und Verarbeitung sind Thema in KB II und KB V.
- Die Übungsfälle vermeiden bewusst die Personen und Auslöser der Klassenarbeit (Frau Sommer, Herr Brenner, Antibiotika-Kurzinfusion), damit die KA den Transfer prüft.

Nicht enthalten (andere Kompetenzbereiche/Fächer)

- KB II: psychologische Erste Hilfe, Beruhigen, Notfalleinwilligung, SPIKES/NURSE, SAfE · KB III: Reanimation, ABCDE-Schema, Notaufnahme/Triage, PTBS (nur Verweise) · KB IV: Delegationsrecht, Haftung, unterlassene Hilfeleistung, Ersthelferschutz, Patientenverfügung · KB V: eigene Überforderung · Deutsch: Notruf absetzen, SBAR · Pädiatrie (3. AJ): Anaphylaxie bei Kindern · Anatomie: Pathophysiologie der Lungenembolie (1. AJ, nur aktiviert).

Liste für die Aufstellung (AA5a) – Lösung

- 🟢 selbst: Infusion stoppen, Zugang belassen · Hilfe holen · nach Leitsymptom lagern · Vitalzeichen messen · dokumentieren
- 🟡 n. ä. A./SOP: Adrenalin i. m. · Sauerstoff · Antihistaminikum · Volumengabe · eigener Autoinjektor nach ärztlichem Notfallplan (der Plan ist die Anordnung)
- 🔴 ärztlich: Diagnose stellen · über weitere Therapie und Überwachungsdauer entscheiden

Lagerungskarten (AA3a) – zum Vorlesen ohne App

Karte	Situation	Lösung und Begründung
Herr Bauer (70)	Nach einem Bienenstich ist ihm schwindelig. Puls 120/min, Blutdruck 85/50 mmHg. Er atmet ruhig und ist ansprechbar.	**flach, Beine hoch** – Schockzeichen ohne Atemnot: Blut aus den Beinen fließt zum Herzen.
Frau Carla Yıldız (55) (Dilemma)	Nach Kontrastmittel ist sie heiser und atmet pfeifend, 30 Atemzüge/min. Blutdruck 90/55 mmHg.	**Oberkörper hoch** – Atemnot ist das Leitsymptom – trotz niedrigem Blutdruck. Beine hoch würde die Atmung erschweren.
Herr Demir (40)	Sturz von einer 4 m hohen Leiter. Er klagt über Nackenschmerzen und Kribbeln in beiden Händen.	**nicht bewegen, Kopf halten** – Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung: Jede Bewegung kann das Rückenmark weiter schädigen.
Frau Engel (63)	Nach einem Wespenstich reagiert sie nicht mehr auf Ansprache. Sie atmet normal.	**stabile Seitenlage** – Bewusstlos mit normaler Atmung: Die Atemwege bleiben frei, Erbrochenes kann abfließen.
Herr Fuchs (81)	Teerstuhl seit dem Morgen. Er ist blass und kaltschweißig, Puls 116/min, Blutdruck 98/72 mmHg, keine Atemnot.	**flach, Beine hoch** – Hypovolämischer Schock ohne Atemnot. Nicht aufsetzen – Kollapsgefahr.
Frau Graf (35)	Sie hat eine Nussallergie und Quaddeln am Hals: „Ich krieg so schlecht Luft." Blutdruck 120/80 mmHg.	**Oberkörper hoch** – Atemnot steht im Vordergrund, der Kreislauf ist noch stabil. Nicht aufstehen lassen.
Herr Hahn (28)	Sturz mit dem Fahrrad, offener Unterschenkelbruch. Er ist blass, Puls 120/min. Keine Nacken- oder Rückenschmerzen.	**flach, verletztes Bein nicht anheben** – Keine Schocklage bei Verletzungen an Bein oder Becken: Bein in der vorgefundenen Lage ruhigstellen (Woche 3).
Herr Ivo (66)	Nach einem Wespenstich ist er bewusstlos und atmet nicht normal.	**Reanimation beginnen (KB III)** – Keine normale Atmung = Kreislaufstillstand. Lagerung: Rückenlage auf harter Unterlage.

Karte	Situation	Lösung und Begründung
Profi-Karte: Frau Jäger (74)	Plötzlich peitschenartiger Schmerz im linken Bein. Das Bein ist blass und kalt, am Fuß ist kein Puls tastbar.	**Bein tief lagern, polstern** – Verdacht auf akuten Arterienverschluss: Tieflagern verbessert die Durchblutung (Examen Mai 2024). Die Lagerung richtet sich immer nach dem Problem.

Drehbuch der Simulation (AA4) – idealer Ablauf und typische Fehler

Variante	Leitsymptom und richtige Schritte	Typische Fehler und ihre Folgen in der App
A Klinik – Herr Kaiser (58), Eisen-Kurzinfusion, Notfall-SOP	Atemnot (Heiserkeit, pfeifende Atmung, SpO_2 ↓) → Infusion stoppen, Zugang belassen · Notfallteam rufen · Oberkörper hoch · Adrenalin i. m. nach SOP · Sauerstoff nach SOP · Vitalzeichen · dokumentieren, Allergie vermerken, Nachbeobachtung	Zugang ziehen (kein Weg für Medikamente) · Beine hoch (Atemnot nimmt zu) · Antihistaminikum statt Adrenalin (keine Besserung) · allein lassen
B Pflegeheim – Frau Gruber (84), neues Schmerzmittel (Tablette), keine Ärztin im Haus, keine SOP	Kreislauf ohne Atemnot (Schwindel, RR ↓, Puls ↑) → Hilfe holen: Pflegefachkraft, Notruf 112 · flach, Beine hoch · nicht aufsetzen · überwachen · keine Medikamente ohne Anordnung · Übergabe an Notärztin, dokumentieren	Zur Toilette begleiten/aufsetzen (Kollaps) · Adrenalin aus dem Notfallkoffer ohne Anordnung · etwas zu trinken geben
C ambulant – Herr Hager (66), Bienenstich, eigenes Notfallset mit ärztlichem Notfallplan	Heiserkeit, dann Bewusstseinstrübung bei erhaltener Atmung → Notruf 112 · Autoinjektor aus dem Notfallset nach Notfallplan (Außenseite Oberschenkel) · bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung stabile Seitenlage · Atmung überwachen · Stachel abstreifen (Biene) · Uhrzeit notieren	Tropfen aus dem Notfallset zuerst (Antihistaminikum; Aspirationsgefahr) · aufrichten · Autoinjektor nicht nutzen und nur warten

Quellen

- S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie, AWMF 061-025, Update 2021 (Ring et al., Allergo J Int 2021;30:1–25) · MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock · Landeslehrplan Berufsfachschule Pflege BW, CE 06 · Ich-kann-Liste KB I (3BFP2) · BW-Abschlussprüfungen Mai 2023–Mai 2026 (Operatoren, Aufgabenformat)

Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock 2 - Thema: Schock	

Schock ist nicht gleich Schock – vergleichen und nach Leitsymptom handeln [LSG]

🎯 **Lernziel:** Sie vergleichen den hypovolämischen, den anaphylaktischen und den neurogenen Schock und begründen Sofortmaßnahmen und Lagerung (Positionierung) anhand des Leitsymptoms. Sie grenzen eigenverantwortliche von ärztlich angeordneten Maßnahmen ab und korrigieren typische Fehlvorstellungen.

📱 = am Smartphone (Stunden-App) ✏️ = auf Papier

Fallbezug: „Reanimation – und nicht nur ich war hilflos“ (Auszug)

Frau Maler, 71 Jahre, ist seit gestern neu im Pflegeheim. Vor drei Wochen erhielt sie nach einer Schenkelhalsfraktur eine Hüft-TEP. Seit der Entlassung liegt sie die meiste Zeit im Bett.

Schülerin Christin berichtet: „Gegen elf Uhr wirkte sie unruhig, atmete schnell und sagte, sie bekomme schlecht Luft. Sie war blass, hatte kalten Schweiß auf der Stirn, ihr Puls lag bei 118/min und der Blutdruck bei 105/70 mmHg. Ich dachte, sie sei nur aufgeregt, weil alles neu für sie ist.“

Aus Woche 1 wissen Sie: Frau Maler war um 11 Uhr im kompensierten Schock (Schockindex ≈ 1,1). Offen blieb, woher die Luftnot kommt. **Meine Vermutung zur Schockform (AA3a, Woche 1):** offen – wird in AA7 geklärt (obstruktiver Schock durch Lungenembolie)

💬 *Woher kommt Frau Malers Luftnot – und wie hätte man sie um 11 Uhr lagern müssen?*

So läuft die Stunde: Scannen Sie den QR-Code **am Beamer** und geben Sie Ihren Vornamen ein. Ihr Handy wechselt dann **automatisch mit dem Beamer** – Sie müssen nichts weiter aufrufen.

Nur falls das nicht klappt: diesen QR-Code scannen und zusätzlich den **Raumcode vom Beamer** eingeben.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2.html

📱 Einstieg: Wie hätten Sie gehandelt? – Ihre Vermutungen, bitte!

⏱️ *8 min · Einzelarbeit → Murmeln (PA) → Plenum · AFB I · Ich-kann-Liste W2 Nr. 4 · Vorwissen aktivieren, Vermutungen bilden, Fehlvorstellungen sichtbar machen; im Check-out werden die Vermutungen überprüft (vorher/nachher)*

📱 *In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer*

Sechs kurze Notfälle – der letzte ist Frau Maler um 11 Uhr: Wie würden Sie handeln? Tippen Sie Ihre Vermutung an und geben Sie an, ob Sie sich sicher sind oder nur vermuten.

Falsch liegen ist jetzt ausdrücklich erlaubt: Genau diese Entscheidungen lernen Sie heute. Am Ende der Stunde stimmen Sie noch einmal ab und prüfen: Hätte ich richtig gehandelt?

Murmeln (1 Minute): Am Beamer sehen Sie, wie die Klasse vermutet – ohne Namen. Wo die Klasse am meisten uneinig ist, überzeugen Sie Ihre Nachbarin oder Ihren Nachbarn: Warum würden Sie so handeln? Aufgelöst wird noch nicht.

Nr.	Richtig	Begründung
E1	B Oberkörper hoch	Atemnot ist das Leitsymptom → Oberkörper hoch. Beine hoch würde die Atmung erschweren.

Nr.	Richtig	Begründung
E2	B Adrenalin i. m.	Adrenalin wirkt am schnellsten auf Kreislauf, Schleimhäute und Bronchien. Antihistaminikum und Kortison kommen danach.
E3	B Nein – das kann ein Schock sein	Neurogener Schock: Der Sympathikus fällt aus – kein Pulsanstieg, keine Zentralisation, aber der Blutdruck ist niedrig.
E4	C stoppen, Zugang liegen lassen	Allergen sofort stoppen – den venösen Zugang braucht das Notfallteam für Medikamente und Volumen.
E5	B Nein, nur nach Anordnung oder SOP	Sauerstoff ist ein Arzneimittel. Eigenverantwortlich: erkennen, Hilfe holen, lagern, überwachen.
E6	B Oberkörper hoch	Die Luftnot steht im Vordergrund → Oberkörper hoch, trotz Schockzeichen keine Schocklage. Nicht aufstehen lassen (Lungenembolie: weitere Gerinnsel können sich lösen), nicht allein lassen, sofort Hilfe holen.

⏱ *Ablauf: Abstimmen (ca. 4 min) → am Beamer die Frage mit der größten Uneinigkeit anklicken (groß) und „Murmeln" einblenden (1 min) → 2–3 Begründungen hören, nicht auflösen. Impuls: „Bei E… sind Sie geteilter Meinung – genau das klären wir heute. Am Ende prüfen Sie Ihre Vermutungen." E6 ist die Leitfrage; sie wird in AA7 geklärt.*

Teil A · Drei Wege in den Schock (Gruppenpuzzle)

Das Gruppenpuzzle hat **zwei Runden**. Ihre Lehrkraft teilt die Gruppen am Beamer zufällig ein – **wer mit wem** arbeitet, zeigt Ihr Handy. Expertinnen und Experten gibt es für **A** (hypovolämischer Schock), **B** (anaphylaktischer Schock) und **C** (neurogener Schock).

① Expertenteam (15 min)
👥 gleicher Buchstabe: **A + A + A**
Fall markieren · Infotext · **Ihre Spalte** der Tabelle · 1.1
✓ „Unsere Spalte ist fertig"

🚶 **umsetzen!** →

② Stammgruppe (12 min)
🧩 **A + B + C** an einem Tisch
reihum erklären · **Tabelle vollständig**
✓ „Unsere Tabelle ist vollständig"

Ich bin Expertin/Experte für: ☐ A ☐ B ☐ C **Expertenteam:** _____ **Stammgruppe:** _____

AA1: Identifizieren – Expertenteam: 🚶 Setzen Sie sich mit Ihrem **Expertenteam** zusammen – die Namen stehen auf Ihrem Handy. **a)** Markieren Sie am Handy im Fall alle Hinweise auf einen Schock. **b)** Lesen Sie den Infotext (Handy; auf Papier freiwillig am Pult). **c)** Füllen Sie gemeinsam **Ihre Spalte** der Vergleichstabelle aus. **d)** Bearbeiten Sie die Klausuraufgabe 1.1. **e)** Machen Sie den Experten-Check am Handy und tippen Sie dann auf „Unsere Spalte ist fertig".

⏱ *15 min · Gruppenarbeit (Expertenteam, 3–4) · AFB I–II · Ich-kann-Liste W2 Nr. 1 · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.1 · Folie 8 zeigt am Beamer, welche Teams fertig sind*

Vergleichstabelle – AA1: Ihre Spalte im Expertenteam · AA2: die anderen Spalten in der Stammgruppe

	A hypovolämisch	B anaphylaktisch	C neurogen
Ursache	Blut- oder Flüssigkeitsverlust (Blutung, z. B. Magen-Darm-Blutung; Verbrennung; Durchfall, Erbrechen)	allergische Sofortreaktion auf Medikament, Insektengift oder Nahrungsmittel	Verletzung des Rückenmarks (meist Halswirbelsäule), z. B. Kopfsprung, Sturz aus der Höhe
Entstehung (kurz)	Volumen ↓ → Rückstrom zum Herzen ↓ → Schlagvolumen ↓ → Blutdruck ↓	Histamin → Gefäße weit und durchlässig → relativer Volumenmangel → Blutdruck ↓; Bronchien eng	Sympathikus fällt aus → Gefäße weit, Blut versackt → Blutdruck ↓; keine Gegenregulation

	A hypovolämisch	**B anaphylaktisch**	**C neurogen**
Puls	schnell, schwach	schnell	langsam oder normal
Haut	blass, kalt, schweißig (Zentralisation)	Juckreiz, Rötung, Quaddeln, Schwellungen (kann auch blass sein)	unterhalb der Verletzung warm, trocken, rosig
weitere typische Zeichen	Durst, Unruhe, schnelle Atmung, wenig Urin; ggf. sichtbares Blut, Teerstuhl	Heiserkeit, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe, Schwindel	Lähmungen, Kribbeln, Taubheit, Nacken-/Rückenschmerz, flache Atmung, Auskühlung
Darauf achte ich besonders	Blutungsquelle; Puls und Blutdruck im Verlauf (Schockindex); Bewusstsein; Urin	Atemwege und Atmung (Heiserkeit, SpO_2); Kreislauf; zweite Reaktion nach Stunden möglich	Atmung; Blutdruck und Puls; Temperatur; nicht bewegen
Gemeinsamkeit	Bei allen drei Formen fällt der Blutdruck, die Organe werden schlecht durchblutet → Sauerstoffmangel → Lebensgefahr. Anaphylaktischer und neurogener Schock sind distributive Schockformen: Die Gefäße sind weit gestellt (relativer Volumenmangel).		

Nr.	**Aufgabe**	**Punkte**
1.1	Begründen Sie anhand von 4 Symptomen aus Ihrer Fallsituation, dass bei der Person ein hypovolämischer (A), anaphylaktischer (B) bzw. neurogener Schock (C) vorliegt.	___ / 4

Tipp wie in der Klassenarbeit: Ordnen Sie jedes Symptom zu (z. B. Kreislauf, Haut, Atemwege) und erklären Sie kurz, was es zeigt. Ohne Kreislaufzeichen gibt es nicht die volle Punktzahl.

A) Herr Albrecht: Ursache: schwarzer, klebriger Stuhl (Teerstuhl) unter Gerinnungshemmer → Blutung im Magen-Darm-Trakt · Kreislauf: Puls 116/min – Anstieg von 78/min (Tachykardie, Gegenregulation) · Kreislauf: Blutdruck 98/72 mmHg – Abfall von 145/85 mmHg, kleine Amplitude; Schockindex 116 : 98 ≈ 1,2 · Haut: blass, Stirn kalt und feucht (Zentralisation) · Volumenmangel: Durst (bittet mehrmals um etwas zu trinken) · Gehirn: Unruhe, neue Verwirrtheit, „schwarz vor Augen“ (Minderdurchblutung) · Atmung: Atemfrequenz 24/min (Frühzeichen)

B) Mia: zeitlicher Zusammenhang: Beginn etwa 10 Minuten nach dem Haselnusskuchen (Allergen) · Haut: Juckreiz, Quaddeln an Hals und Brust, Schwellung von Lippen und Augenlidern · Atemwege: heisere Stimme (Schwellung der Kehlkopfschleimhaut), Atemfrequenz 26/min, SpO_2 93 % · Kreislauf: Blutdruck 88/50 mmHg – deutlich unter ihrem üblichen Wert (120/70); Puls 128/min (Tachykardie) · Magen-Darm: Übelkeit, Bauchkrämpfe · Gehirn/Kreislauf: Schwindel

C) Herr Weber: Ursache: Kopfsprung in flaches Wasser, starke Nackenschmerzen → Verletzung der Halswirbelsäule · Kreislauf: Blutdruck 82/45 mmHg (niedrig) · Kreislauf: langsamer Puls 52/min trotz niedrigem Blutdruck – der Sympathikus fällt aus · Haut: an den Beinen warm, trocken, rosig (keine Zentralisation) · Nerven: Lähmungen (Arme und Beine kaum beweglich), „Ich spür meine Beine nicht“, Kribbeln in den Händen · Atmung: flach (hohe Verletzung)

(je Symptom mit Zuordnung 1 P.; Werte nur mit Vorwert-Vergleich voll werten; für die volle Punktzahl muss die Kreislaufbeteiligung genannt sein – vgl. Erwartungshorizont KA, Aufg. 3.1)

AA2: Vergleichen – Stammgruppe: a) Umsetzen! Setzen Sie sich mit Ihrer **Stammgruppe** zusammen – Namen und Tischkarte zeigt Ihr Handy. Erklären Sie reihum **A → B → C** (je 3 Minuten, die Uhr läuft am Beamer). Die anderen füllen ihre Spalten der Vergleichstabelle aus. Zum Schluss gemeinsam: die Gemeinsamkeit. Dann am Handy: „Unsere Tabelle ist vollständig".

20 min (a–c) · Gruppenarbeit (Stammgruppe 3–4) · AFB II · Ich-kann-Liste W2 Nr. 1 · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.2 und 5.5 · Folie 9 zeigt am Beamer, welche Stammgruppen fertig sind

b) Schockform-Detektiv:

In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer

Bestimmen Sie bei sechs kurzen Fällen die Schockform und markieren Sie die **zwei Befunde**, die Ihre Entscheidung belegen. Im **Monitorvergleich** finden Sie die Unterschiede zwischen zwei Patienten.

Am Ende: Ergänzen Sie den Merksatz.

Merksatz AA2

Bei allen drei Schockformen **fällt** der Blutdruck, und die Organe werden schlecht durchblutet. Beim neurogenen Schock fällt der **Sympathikus** aus: Der Puls ist **langsam** oder normal, und die Haut ist **warm** und trocken.

c) Klausurtraining: Bearbeiten Sie die Aufgaben allein. Danach prüft **Expertin/Experte B** Ihre Antwort zu 2.1 und **Expertin/Experte C** Ihre Antwort zu 2.2.

Nr.	Aufgabe	Punkte
2.1	Erläutern Sie, wie es bei Mia zum Schock kommt. – Tipp: Denken Sie in einer Pfeilkette – Auslöser → Botenstoff → Gefäße → Blutdruck; die Atemwege extra.	___ / 3
2.2	Nennen Sie 1 Befund, der bei Herrn Weber anders ist als bei Herrn Albrecht. Begründen Sie den Unterschied.	___ / 2

2.1

Die Haselnuss (Allergen) löst eine allergische Sofortreaktion aus: Mastzellen setzen Histamin und weitere Botenstoffe frei.

Die Gefäße werden weit und durchlässig: Flüssigkeit tritt ins Gewebe (Quaddeln, Schwellung von Lippen und Lidern), im Gefäßsystem fehlt Volumen → der Blutdruck fällt (88/50 mmHg), das Herz gleicht mit 128/min aus.

Zusätzlich schwellen die Schleimhäute an (Heiserkeit) und die Bronchien verengen sich → Atemnot, Sauerstoffmangel (SpO_2 93 %).

(je schlüssiger Schritt 1 P.)

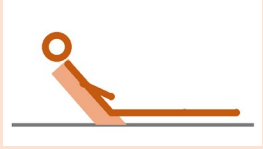
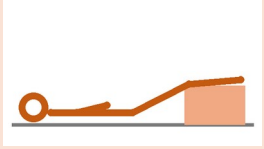
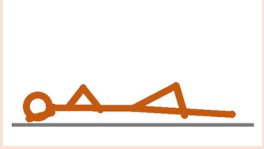
2.2

Befund: Herr Weber hat einen langsamen Puls (52/min), Herr Albrecht einen schnellen (116/min). – oder: Herr Webers Haut ist warm, trocken, rosig, Herrn Albrechts Haut blass, kalt, schweißig.

Begründung: Bei Herrn Weber ist das Rückenmark verletzt, der Sympathikus fällt aus. Der Körper kann nicht gegenregulieren: kein Pulsanstieg, keine Zentralisation. (Befund 1 P., Begründung 1 P.)

AA3: Begründen – Lagerung (Positionierung) nach Leitsymptom: Aus dem Erste-Hilfe-Kurs kennen viele: Schock → Beine hoch. Das stimmt nicht immer. Entscheidend ist das **Leitsymptom** – das Zeichen, das die Person gerade am meisten gefährdet.

20 min · Partnerarbeit (Yogamatte) → Einzelarbeit · AFB II · Ich-kann-Liste W2 Nr. 2 und 4 · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.3

			
Oberkörper hoch (halbsitzend) **Wann?** Atemnot steht im Vordergrund. **Warum?** Die Atemhilfsmuskulatur kann besser arbeiten, die Bauchorgane drücken nicht gegen das Zwerchfell.	**Flach, Beine hoch (Schocklage)** **Wann?** Schockzeichen ohne Atemnot. **Warum?** Blut aus den Beinen fließt zum Körperstamm, das Herz bekommt mehr Blut. Nicht bei Atemnot und nicht bei Verletzungen an Beinen, Becken oder Wirbelsäule.	**Stabile Seitenlage** **Wann?** Bewusstlos, Atmung normal. **Warum?** Die Atemwege bleiben frei, Erbrochenes kann abfließen. Nach einem Unfall nur achsengerecht drehen.	**Nicht bewegen** **Wann?** Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung. **Warum?** Jede Bewegung kann das Rückenmark weiter schädigen. Kopf mit beiden Händen halten (Woche 4).

⚠ **Bei Anaphylaxie:** nicht aufsitzen, aufstehen oder gehen lassen – das Blut kann „versacken“, ein Kreislaufstillstand droht. **Atmet die Person nicht normal → Reanimation** (KB III).

Quelle: nach S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); Ich-kann-Liste KB I; sprachlich vereinfacht.

a) Lagerungsparcours (Partnerarbeit auf der Yogamatte):

In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer

Die App zieht eine Situationskarte. **Person A lagert Person B** innerhalb von 60 Sekunden und begründet: „Ich lagere …, weil …“. Dann tippen Sie auf **Aufdecken** und vergleichen. Wechseln Sie nach jeder Karte die Rollen.

Sicherheit: behutsam lagern, nicht heben. Wer nicht gelagert werden möchte, übernimmt die Begründung. **Am Ende:** Ergänzen Sie den Merksatz.

Merksatz AA3

Die Lagerung richtet sich nach dem **Leitsymptom**, nicht nach der Schockform: Atemnot → **Oberkörper hoch**; Schockzeichen ohne Atemnot → **flach, Beine hoch**; bewusstlos mit normaler Atmung → **stabile Seitenlage**; Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung → **nicht bewegen**.

b) Entscheidungsweg: Ergänzen Sie, wie Sie lagern. Prüfen Sie die Fragen **von oben nach unten** – die erste Frage, die Sie mit „Ja“ beantworten, entscheidet.

Frage	„Ja“ → so handle bzw. lagere ich
1. Atmet die Person **nicht normal**?	Reanimation beginnen (KB III)
2. Ist sie **bewusstlos**, atmet aber normal?	stabile Seitenlage (nach Unfall achsengerecht)
3. Gibt es Hinweise auf eine **Wirbelsäulenverletzung**?	nicht bewegen, Kopf mit beiden Händen halten
4. Steht **Atemnot** im Vordergrund?	Oberkörper hoch (halbsitzend)
5. **Schockzeichen** ohne Atemnot?	flach, Beine hoch

c) Klausurtraining:

Nr.	Aufgabe	Punkte
3.1	*Frau Carla Yıldız (55) hat in der Radiologie Kontrastmittel erhalten. Sie ist heiser und atmet pfeifend mit 30 Atemzügen pro Minute. Ihr Blutdruck liegt bei 90/55 mmHg.* Begründen Sie, warum Sie Frau Yıldız trotz des niedrigen Blutdrucks mit erhöhtem Oberkörper lagern.	___ / 2
3.2	Nehmen Sie Stellung zu der Aussage: „Bei einem Schock legt man immer die Beine hoch.“	___ / 2

3.1

Bei Frau Yıldız steht die Atemnot im Vordergrund (Heiserkeit, pfeifende Atmung, 30/min). Mit erhöhtem Oberkörper kann sie die Atemhilfsmuskulatur einsetzen, die Bauchorgane drücken nicht gegen das Zwerchfell.

Flach mit Beinen hoch würde die Atemnot verstärken. Nicht aufsetzen oder aufstehen lassen, Kreislauf engmaschig überwachen. (je schlüssiges Argument 1 P.)

3.2

Die Aussage ist falsch. Die Schocklage hilft nur bei Schockzeichen ohne Atemnot, weil Blut aus den Beinen zum Herzen fließt.

Entscheidend ist das Leitsymptom: bei Atemnot Oberkörper hoch, bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung stabile Seitenlage, bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung nicht bewegen; bei Verletzungen an Beinen oder Becken keine Schocklage. (Beurteilung 1 P., Begründung mit Gegenbeispiel 1 P.)

Teil B · Anaphylaxie – im Team handeln

AA4: Ableiten – Notfall-Simulation: Sie arbeiten in Ihrer Stammgruppe. Die App spielt die Patientin oder den Patienten und zeigt einen Monitor. **Was Sie tun, verändert die Werte.** Verteilen Sie die Rollen:

⏱ *25 min · Gruppenarbeit (Stammgruppe 3–4) → Plenum · AFB II · Ich-kann-Liste W2 Nr. 3 · Lehrplan CE 06: Simulation von Notfallsituationen, I.4.a*

🩺 Pflegefachperson	📟 Monitor & Stimme	📝 Protokoll
Entscheidet und wählt in der App die Handlungen aus. Sagt laut, was sie tut und warum.	Bedient das Handy, liest die Aussagen der Patientin/des Patienten und die Werte laut vor.	Führt das Notfallprotokoll (Anlage): Uhrzeit, Werte, Maßnahme, Grundlage. In 4er-Gruppen zusätzlich: Beobachtung (Lagerung, Verantwortung).

📱 *In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer*

Spielen Sie die drei Varianten nacheinander (je ca. 6 Minuten) und **wechseln Sie nach jeder Runde die Rollen**:

A – Klinik: Herr Kaiser (58), Eisen-Kurzinfusion · **B – Pflegeheim:** Frau Gruber (84), neues Schmerzmittel · **C – ambulante Pflege:** Herr Hager (66), Bienenstich, eigenes Notfallset

Nach jeder Runde zeigt die App einen **Zeitstrahl**. Vergleichen Sie ihn mit Ihrem Protokoll. Nach der dritten Runde: Ergänzen Sie den Merksatz.

Merksatz AA4
Anaphylaxie: Allergen **stoppen**, Hilfe holen, lagern nach **Leitsymptom**, **Adrenalin** i. m. nach

Anordnung oder SOP, überwachen und **dokumentieren**.

b) Nachbesprechung: Es war jedes Mal ein anaphylaktischer Schock. **Begründen** Sie, warum Sie in den drei Varianten trotzdem unterschiedlich gelagert haben.

Die Lagerung richtet sich nach dem Leitsymptom: A (Herr Kaiser) Atemnot → Oberkörper hoch; B (Frau Gruber) Kreislaufzeichen ohne Atemnot → flach, Beine hoch; C (Herr Hager) bewusstlos mit normaler Atmung → stabile Seitenlage.

c) Klausurtraining: Vergleichen Sie die Klinik (Variante A) mit dem Pflegeheim (Variante B).

Nr.	Aufgabe	Punkte
4.1	Nennen Sie 3 Maßnahmen, die Sie bei Herrn Kaiser zusätzlich zu den Maßnahmen bei Frau Gruber durchführen dürfen oder müssen. Begründen Sie jede Maßnahme.	___ / 3

z. B.: Infusion sofort stoppen, venösen Zugang belassen – das Allergen fließt sonst weiter; den Zugang braucht das Notfallteam für Medikamente und Volumen.

Adrenalin 0,5 mg i. m. in die Außenseite des Oberschenkels nach Notfall-SOP – die SOP erlaubt Pflegefachpersonen die Gabe (bei Frau Gruber gibt es keine Anordnung und keine SOP).

Sauerstoff nach SOP (Maske mit Reservoir) – Atemnot, SpO_2 ↓; die SOP erlaubt die Gabe.

Volumengabe nach ärztlicher Anordnung vorbereiten – der Zugang liegt bereits.

Notfallteam der Klinik statt Notruf 112 – Ärztin ist im Haus und schnell da.

(je Maßnahme mit Begründung 1 P., max. 3 P.)

AA5: Unterscheiden – Wer darf was? a) Aufstellung: Ihre Lehrkraft liest Maßnahmen vor. Stellen Sie sich in die passende Ecke des Raums und **begründen** Sie Ihre Wahl. Tragen Sie danach die Maßnahmen aus dem Wortspeicher in die Tabelle ein.

⏱ 12 min (a und b) · Plenum (Aufstellung) → Einzelarbeit → Partnerarbeit → Plenum · AFB II–III · Ich-kann-Liste W2 Nr. 3 und 4 · Kompetenz III.2.b

Wortspeicher

Infusion stoppen, Zugang belassen · Hilfe holen (Notfallteam bzw. 112) · nach Leitsymptom lagern · Puls, Blutdruck, Atmung, SpO_2 messen · Adrenalin i. m. geben · Sauerstoff geben · Antihistaminikum geben · Infusion zur Volumengabe anschließen · eigenen Autoinjektor nach dem ärztlichen Notfallplan anwenden · Diagnose „anaphylaktischer Schock“ stellen · Ereignis dokumentieren · über weitere Therapie und Dauer der Überwachung entscheiden

🟢 mache ich selbst (eigenverantwortlich)	🟡 nur nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) oder SOP	🔴 ärztliche Aufgabe
Infusion stoppen, Zugang belassen; Hilfe holen (Notfallteam bzw. 112); nach Leitsymptom lagern; Puls, Blutdruck, Atmung, SpO_2 messen; Ereignis dokumentieren	Adrenalin i. m.; Sauerstoff; Antihistaminikum; Infusion zur Volumengabe; eigenen Autoinjektor nach dem Notfallplan (der Plan ist die ärztliche Anordnung für diese Person)	Diagnose stellen; über weitere Therapie und Dauer der Überwachung entscheiden; Medikamente anordnen

Informationstext: Verantwortung im Notfall

„[Pflegefachpersonen] treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten lebenserhaltende Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der

Ärztin oder des Arztes ein.“ (PflAPrV, Anlage 1, I.4.a; vgl. § 5 PflBG)

Eigenverantwortlich: Gefahr erkennen, Hilfe holen, Allergen stoppen, lagern, überwachen, dokumentieren.

Nur nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) oder SOP: Medikamente – auch Adrenalin –, Sauerstoff und Infusionen. Eine **Notfall-SOP** ist eine schriftliche, ärztlich freigegebene Handlungsanweisung der Einrichtung für eine bestimmte Notfallsituation. Pflegende „wirken … an der Durchführung ärztlich veranlasster Maßnahmen … mit“ (III.2.b).

Als Auszubildende/r: unter Anleitung handeln, sofort eine Pflegefachperson holen, die eigenen Grenzen kennen.

b) Adrenalin oder Antihistaminikum? Lesen Sie den Informationstext und den Dialog.

Problem bei der Anaphylaxie	Wirkung von Adrenalin
Gefäße weit → Blutdruck fällt	Gefäße eng → Blutdruck steigt
Schleimhäute geschwollen (Kehlkopf, Lippen)	Schleimhäute schwellen ab
Bronchien eng → Atemnot	Bronchien weit
Herz muss mehr leisten	Herz schlägt kräftiger
Mastzellen setzen weiter Histamin frei	weniger Histamin wird freigesetzt

Adrenalin wirkt von allen Notfallmedikamenten bei Anaphylaxie **am schnellsten**. Erwachsene erhalten 0,3–0,5 mg in den Muskel an der **Außenseite des Oberschenkels** (auch als Fertigspritze, sog. Autoinjektor); nach 5–10 Minuten kann die Gabe wiederholt werden. **Antihistaminika** blockieren nur die Histamin-Wirkung, wirken langsamer und haben keine belegte Wirkung auf Kreislauf und Bronchien. **Glukokortikoide** (Kortison) wirken erst nach Stunden. Beide kommen erst **nach** Adrenalin – sie ersetzen es nicht.

Quelle: nach S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

💬 **Herr Brandt, Pflegefachkraft:**
„Geben Sie ihr erst mal das Antihistaminikum aus dem Notfallkoffer. Adrenalin ist mir zu heftig.“

💬 **Lina, Auszubildende:**
„Aber in unserer Notfall-SOP steht Adrenalin ganz oben …“

Think: Wer hat recht? Notieren Sie zwei Argumente (2 Min.). **Pair:** Vergleichen Sie mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner (2 Min.). **Share:** Einige Paare stellen vor.

Nr.	Aufgabe	Punkte
5.1	Nehmen Sie Stellung zu der Aussage von Herrn Brandt.	___ / 3

Die Aussage ist fachlich falsch. Beim anaphylaktischen Schock ist Adrenalin i. m. das Mittel der ersten Wahl (nach SOP bzw. ärztlicher Anordnung): Es stellt die Gefäße eng und hebt den Blutdruck, lässt die Schleimhäute abschwellen, weitet die Bronchien und wirkt am schnellsten.

Ein Antihistaminikum blockiert nur Histamin, wirkt langsamer und hebt weder den Blutdruck noch weitet es die Bronchien. Es darf Adrenalin nicht verzögern und kann danach gegeben werden.

Lina sollte die SOP ansprechen und sofort das Notfallteam bzw. die Ärztin einbeziehen. (Beurteilung 1 P., je fachliches Argument 1 P., max. 3 P.)

Klausurtraining: Sofortmaßnahmen ableiten und dokumentieren

AA6: Klausurtraining – Transferfall: Lösen Sie die Aufgaben **allein und ohne Unterlagen** (ca. 8 Minuten). Tauschen Sie dann mit einer Person aus einer **anderen** Stammgruppe. Bewerten Sie deren Lösung mit dem **Bewertungsraster in der App** und geben Sie eine Rückmeldung in einem Satz.

15 min · Einzelarbeit → Peer-Korrektur mit App-Raster · AFB I–III · KA-Format (KB 1, Aufg. 3.3) · Examensvorbild: Mai 2024 Tag 3, Aufg. 8.2; Mai 2026 Tag 1, Aufg. 3.2

Fallsituation

Sie sind in der Tagespflege „Sonnenhof“ eingesetzt. Herr Klaus Martens (74) hat einen Diabetes mellitus Typ 2 und eine Herzinsuffizienz. Gegen 14:15 Uhr sitzt er mit anderen Gästen auf der Terrasse beim Kaffee. Plötzlich schreit er auf: Eine Wespe hat ihn in die Oberlippe gestochen.

Nach etwa fünf Minuten ist seine Oberlippe stark geschwollen, am Hals bilden sich Quaddeln. Mit kloßiger Stimme sagt er: „Mir ist so eng im Hals.“ Beim Einatmen hören Sie ein pfeifendes Geräusch. Sie messen: Atemfrequenz 28/min, Puls 124/min, Blutdruck 92/60 mmHg (am Morgen: 150/85 mmHg). In der Tagespflege ist keine Ärztin anwesend. Ein Notfallset hat Herr Martens nicht dabei.

Pflegefachpersonen treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten lebenserhaltende Sofortmaßnahmen ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
6.1	Beschreiben Sie stichwortartig 5 Sofortmaßnahmen, die Sie bei Herrn Martens bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes einleiten. Begründen Sie dabei die Positionierung von Herrn Martens.	___ / 6
6.2	Kennzeichnen Sie in Ihrer Antwort zu 6.1 jede Maßnahme, die Sie nur nach ärztlicher Anordnung durchführen dürfen, mit „n. ä. A.“.	___ / 1
6.3	*Der Rettungsdienst hat Herrn Martens übernommen.* Nennen Sie 6 Informationen, die Sie in der Pflegedokumentation festhalten.	___ / 3

6.1 und 6.2

z. B.: Hilfe holen: eine Kollegin setzt den Notruf 112 ab (Notärztin nötig); Herrn Martens nicht allein lassen.

Oberkörper hoch (halbsitzend), weil Atemnot und Schwellung im Vordergrund stehen (Kloßgefühl, pfeifende Einatmung, 28/min): Die Atemhilfsmuskulatur kann arbeiten. Keine Schocklage – auch wegen der Herzinsuffizienz. Nicht aufstehen oder gehen lassen.

Vitalzeichen engmaschig überwachen: Atmung, Puls, Blutdruck, Bewusstsein, wenn vorhanden SpO_2 (Schockindex 124 : 92 ≈ 1,3).

Beengende Kleidung am Hals öffnen; Einstichstelle zusätzlich kühlen (Kühlpack in ein Tuch gewickelt).

Nichts zu essen oder zu trinken geben (Schwellung, Aspirationsgefahr).

Adrenalin i. m. (n. ä. A.) – gibt hier die Notärztin, da keine Anordnung und kein Notfallset vorliegen; Sauerstoff (n. ä. A.).

Uhrzeit, Werte und Maßnahmen notieren; bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung stabile Seitenlage, ohne normale Atmung Reanimation (KB III).

6.1: je beschriebene Maßnahme 1 P. (max. 5), Begründung der Positionierung 1 P.; Schocklage trotz Atemnot oder Antihistaminikum statt Adrenalin wird nicht gewertet. 6.2: 1 P., wenn alle Medikamenten- und Sauerstoff-Maßnahmen mit „n. ä. A.“ gekennzeichnet sind.

6.3

z. B. (je 0,5 P.): Uhrzeit des Stichs und Beginn der Beschwerden · Auslöser (Wespenstich Oberlippe) · Symptome (Lippenschwellung, Quaddeln, Kloßgefühl, pfeifende Atmung) · Vitalwerte mit Uhrzeit (AF

28/min, Puls 124/min, RR 92/60 mmHg, Vorwert 150/85) · Maßnahmen mit Uhrzeit und Namenskürzel (Notruf, Lagerung, Überwachung) · Übergabe an den Rettungsdienst (Uhrzeit, Zielklinik) · Information der Angehörigen bzw. Hausärztin · Insektengiftallergie in der Akte vermerken · Hinweis auf Nachbeobachtung wegen möglicher zweiter Reaktion (zweigipfliger Verlauf) weitergeben.

📱 *In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer*

Peer-Korrektur: Das Bewertungsraster erscheint auf Ihrem Handy. Haken Sie ab, was Ihre Partnerin oder Ihr Partner geschrieben hat. Die App zählt die Punkte – wie im Erwartungshorizont der Klassenarbeit.

Meine Punkte: ____ / 10 · Das muss ich noch üben:

_____

Teil C · Zurück zu Frau Maler

AA7: Erklären – Placemat: Arbeiten Sie zu viert mit der Placemat (A3). Jede Person übernimmt ein **Außenfeld** – einen Zeitpunkt aus Christins Bericht – und notiert still: Was steckt dahinter? Gehört es zur Kette? Was hätte Christin selbst tun können? (3 Min.) Drehen Sie die Placemat und lesen Sie die anderen Felder (3 Min.). **Einigen Sie sich in der Mitte** auf die Kausalkette und beantworten Sie gemeinsam die Leitfrage (4 Min.).

⏱ *15 min · Gruppenarbeit (4er, Placemat) → Plenum · AFB III · Ich-kann-Liste W2 Nr. 5 · Brücke zu Woche 4 (Aspiration) und Woche 7 (Thrombose)*

Tipp: Erinnern Sie sich an die Thromboseprophylaxe aus dem 1. Ausbildungsjahr. Nicht jeder Zeitpunkt gehört zur Kette!

Lösung Placemat

Feld Wade (morgens): Wade dick, Schmerz beim Auftreten → Verdacht auf tiefe Beinvenenthrombose (Immobilität nach Hüft-TEP, Angst vor Luxation). Gehört zur Kette. Christin: sofort weitergeben, nicht massieren, nicht mobilisieren bis zur ärztlichen Abklärung.

Feld Frühstück: verschluckt sich, hustet kräftig → leichte Atemwegsverlegung; Husten lassen war richtig. Gehört **nicht** zur Kette (Woche 4).

Feld 11 Uhr: Luftnot, P 118, RR 105/70, blass, kaltschweißig, unruhig → Lungenembolie mit obstruktivem Schock (kompensiert, Schockindex ≈ 1,1). Sofort Hilfe holen, Oberkörper hoch, nicht mobilisieren, nicht allein lassen, überwachen.

Feld Mittag: zyanotisch, keine Reaktion, kein Puls → Kreislaufstillstand; Hilfe rufen, Reanimation (KB III).

Mitte (Kette): Immobilität → tiefe Beinvenenthrombose → Lungenembolie → obstruktiver Schock → Kreislaufstillstand.

Klausurtraining (in der Stunde beginnen, zu Hause fertigstellen):

Frau Maler zeigte bereits Stunden vor dem Kreislaufstillstand Warnzeichen.

Nr.	Aufgabe	Punkte
7.1	Erläutern Sie in Bezug auf die Situation von Frau Maler, wie es von ihrer Immobilität bis zum Kreislaufstillstand kommen konnte.	___ / 5
7.2	Beschreiben Sie 3 Maßnahmen, die um 11 Uhr hätten eingeleitet werden müssen. Begründen Sie die Positionierung von Frau Maler.	___ / 4

7.1

Nach der Hüft-TEP liegt Frau Maler aus Angst vor einer Luxation fast nur im Bett (Immobilität) → das Blut

fließt in den Beinvenen langsamer und gerinnt nach der Operation leichter → tiefe Beinvenenthrombose (rechte Wade dick, schmerzt beim Auftreten) – trotz Heparin.

Ein Teil des Gerinnsels löst sich (möglicherweise beim Aufsetzen an der Bettkante) und wird über das rechte Herz in die Lungenarterie geschwemmt → Lungenembolie: Das Blut kann nicht mehr ungehindert durch die Lunge fließen.

Das linke Herz bekommt zu wenig Blut, das Herzzeitvolumen sinkt → obstruktiver Schock (11 Uhr: Luftnot, Puls 118/min, Blässe, kalter Schweiß, Unruhe; Schockindex ≈ 1,1).

Ohne Behandlung dekompensiert der Kreislauf → Kreislaufstillstand (Mittag: Zyanose, kein Puls). (je schlüssiges Glied mit Fallbezug 1 P., max. 5 P.)

7.2

z. B.: Sofort eine Pflegefachkraft holen bzw. Ärztin oder Notruf – Verdacht auf Lungenembolie mit Schockzeichen, nicht abwarten.

Oberkörper hoch lagern, weil die Luftnot im Vordergrund steht (Atemhilfsmuskulatur); keine Schocklage.

Nicht aufstehen oder mobilisieren lassen (weitere Gerinnsel könnten sich lösen); nicht allein lassen.

Vitalzeichen engmaschig: Puls, Blutdruck, Atemfrequenz, SpO_2, Bewusstsein; Sauerstoff n. ä. A. oder SOP; Beobachtungen mit Uhrzeit dokumentieren und weitergeben.

(je Maßnahme 1 P., Begründung der Positionierung 1 P.)

Check-out: Hätten Sie richtig gehandelt? – Prüfen Sie Ihre Vermutungen

⏱ *5 min · Einzelarbeit → Plenum · Vermutungen überprüfen (vorher/nachher), Lernzuwachs sichtbar machen, Lernstandsdiagnose; Verbindung zur Klausurvorbereitung*

📱 *In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer*

Jetzt wissen Sie mehr. Entscheiden Sie **dieselben sechs Notfälle** noch einmal – Ihr Handy zeigt sie automatisch. Danach sehen Sie die Auflösung – und Ihre Vermutungen vom Stundenbeginn daneben.

Vergleichen Sie am Beamer: Bei welcher Frage hat sich die Klasse am stärksten verändert?

Ich-kann-Liste Woche 2: Schätzen Sie sich ein: ☺ sicher · 😐 teilweise · ☹ noch nicht. Bei 😐 oder ☹ notieren Sie, wo Sie nachlesen.

Ich kann …	☺ 😐 ☹	Nachlesen in …
1. … den hypovolämischen, den anaphylaktischen und den neurogenen Schock vergleichen.		AA1, AA2
2. … die Lagerung nach Leitsymptom beschreiben und begründen.		AA3, AA4b
3. … Sofortmaßnahmen bei einem anaphylaktischen Schock ableiten und meine Verantwortung beschreiben.		AA4, AA5, AA6
4. … falsche Aussagen zum Schock identifizieren und die Korrektur fachlich begründen.		Einstieg, AA3.2, AA5.1
5. … am Fall Frau Maler die Kausalkette bis zum Kreislaufstillstand erklären.		AA7

Zurück zur Leitfrage: *Woher kommt Frau Malers Luftnot – und wie hätte man sie um 11 Uhr lagern müssen?*

Die Luftnot kommt von einer Lungenembolie: Ein Gerinnsel aus der Beinvene hat die Lungenstrombahn verlegt → obstruktiver Schock. Um 11 Uhr: Oberkörper hoch (Luftnot im Vordergrund), nicht mobilisieren, nicht allein lassen, sofort Hilfe holen und engmaschig überwachen.

Hausaufgabe · Klausurtraining wie im Examen

Bearbeitungszeit: ca. 26 Minuten · Hilfsmittel: keine · 20 Punkte – Lösen Sie die Aufgaben wie in einer Prüfung. Kontrollieren Sie sich danach selbst mit der App.

⏱ *ca. 26 min (1,3 min je Punkt wie im Examen) · Einzelarbeit zu Hause · AFB I–III · Examensformat: Ausgangssituation, Rahmensatz je Aufgabe, Situationswechsel im Aufgabenstamm (vgl. Mai 2024 Tag 1, 1.2; Mai 2024 Tag 3, 8.1–8.2; Mai 2026 Tag 1, 1.3)*

Ausgangssituation

Sie arbeiten als Auszubildende bzw. Auszubildender im zweiten Ausbildungsdrittel in der orthopädischen Rehabilitationsklinik „Talblick“. Frau Sabine Lorenz (52) ist seit einer Woche nach einer Bandscheibenoperation an der Lendenwirbelsäule bei Ihnen. Sie ist verheiratet, arbeitet als Bankkauffrau und möchte „so schnell wie möglich wieder fit sein“. In ihrem Allergiepass steht eine Fischallergie. Ihr Notfallset hat sie zu Hause vergessen.

Beim Mittagessen um 12:20 Uhr isst sie Gemüsecurry. Erst später stellt sich heraus, dass die Soße mit Fischsauce gewürzt war. Um 12:35 Uhr klingelt Frau Lorenz. Sie kratzt sich an den Händen und an der Kopfhaut, am Bauch sind Quaddeln zu sehen. Sie sagt: „Mir ist so schwindelig und übel.“ Sie ist blass und unruhig. Sie messen: Puls 124/min, Blutdruck 86/52 mmHg, Atemfrequenz 20/min, Sauerstoffsättigung 96 %. Bei der Morgenrunde lagen der Blutdruck bei 128/78 mmHg und der Puls bei 72/min. Ihre Stimme klingt normal, sie hat keine Atemnot. Die Stationsärztin ist im Haus erreichbar; für allergische Notfälle gibt es eine Notfall-SOP.

Aufgabe 1 (7 Punkte)

Pflegefachpersonen schätzen akute Situationen anhand von Beobachtungen und Messwerten ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
1.1	Beurteilen Sie aus pflegerischer Perspektive die im vorliegenden Fall beschriebenen Messdaten von Frau Lorenz: a) Puls b) Blutdruck	___ / 3
1.2	Begründen Sie anhand von 4 Symptomen aus der Situation, dass bei Frau Lorenz ein anaphylaktischer Schock vorliegt.	___ / 4

1.1 a) Puls 124/min: deutlich erhöht (Tachykardie), Anstieg von 72/min → der Kreislauf versucht auszugleichen. (1,5 P.)

1.1 b) Blutdruck 86/52 mmHg: zu niedrig, deutlicher Abfall vom Vorwert 128/78 mmHg; Schockindex 124 : 86 ≈ 1,4 (über 1) → spricht für einen Schock. (1,5 P.)

1.2 z. B. (je Symptom mit Zuordnung 1 P.): zeitlicher Zusammenhang – Beginn 15 Min. nach dem Essen mit Fischsauce bei bekannter Fischallergie · Haut – Juckreiz an Händen und Kopfhaut, Quaddeln am Bauch · Kreislauf – Puls 124/min, Blutdruckabfall von 128/78 auf 86/52 mmHg, Blässe, Schwindel · Magen-Darm – Übelkeit · Gehirn – Unruhe (Minderdurchblutung).

Für die volle Punktzahl muss die Kreislaufbeteiligung genannt sein (wie in der Klassenarbeit).

Aufgabe 2 (9 Punkte)

Pflegefachpersonen treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten Sofortmaßnahmen ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
2.1	Beschreiben Sie stichwortartig 6 Sofortmaßnahmen, die Sie bei Frau Lorenz einleiten. Begründen Sie die Positionierung.	___ / 7
2.2	*Fünf Minuten später ist Frau Lorenz heiser und sagt: „Ich krieg so schlecht Luft.“ Die Sauerstoffsättigung sinkt auf 90 %.* Begründen Sie, wie Sie Frau Lorenz jetzt positionieren.	___ / 2

2.1 z. B.: nicht weiteressen (Allergen stoppen) · Hilfe holen: Stationsärztin bzw. Notfallteam alarmieren, Frau Lorenz nicht allein lassen · flach lagern, Beine hoch, weil Kreislaufzeichen ohne Atemnot im Vordergrund stehen → mehr Blut zum Herzen; nicht aufsetzen oder aufstehen lassen · Adrenalin i. m. nach Notfall-SOP bzw. ärztlicher Anordnung vorbereiten/verabreichen (Außenseite Oberschenkel) · venösen Zugang und Volumengabe n. ä. A. vorbereiten · Sauerstoff n. ä. A./SOP · Vitalzeichen engmaschig (Puls, Blutdruck, Atmung, SpO_2, Bewusstsein) · Uhrzeit, Symptome und Maßnahmen dokumentieren.

(je Maßnahme 1 P., max. 6 P.; Begründung der Positionierung 1 P.; Antihistaminikum statt Adrenalin wird nicht gewertet)

2.2 Jetzt Oberkörper hoch (halbsitzend), weil die Atemnot im Vordergrund steht (Heiserkeit = Schleimhautschwellung, SpO_2 90 %): Die Atemhilfsmuskulatur kann arbeiten. Trotzdem nicht auf die Bettkante setzen oder aufstehen lassen; Kreislauf weiter überwachen und die Ärztin über die Verschlechterung informieren. (Positionierung 1 P., Begründung 1 P.)

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Pflegefachpersonen steuern den Pflegeprozess auch nach einem Notfall.

Nr.	Aufgabe	Punkte
3.1	*Frau Lorenz geht es nach der Behandlung besser. Die Ärztin ordnet an, sie 24 Stunden lang zu überwachen.* Formulieren Sie 1 Pflegeproblem von Frau Lorenz im PESR-Format.	___ / 4

P: Frau Lorenz ist gefährdet, erneut eine anaphylaktische Reaktion bis hin zum Schock zu entwickeln (zweigipfliger Verlauf möglich).

E: Fischallergie; anaphylaktischer Schock um 12:35 Uhr nach Fischsauce; Notfallset nicht vorhanden.

S: (Risiko – darauf wird geachtet) Juckreiz, Quaddeln, Heiserkeit, Atemnot, Schwindel, Puls ↑, Blutdruck ↓.

R: kennt ihre Allergie und hat einen Allergiepass; ist wach und kann Beschwerden sofort mitteilen; möchte rasch wieder gesund werden. (je P, E, S, R 1 P.)

Selbstkontrolle: Die App zeigt die Musterlösung erst, wenn Sie bestätigen, dass Ihre Antwort auf dem Papier steht. Dann haken Sie ab und zählen Ihre Punkte.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-transfer.html

Meine Punkte: ____ / 20 · Das muss ich noch üben:

_____

📖 **Nachlesen:** Alles aus dieser Stunde – Expertentexte, Merksätze, Lösungen der Übungen und Klausuraufgaben – zum Wiederholen vor der Klassenarbeit.

Erst nach der Stunde scannen: Solange die Stunde am Beamer läuft, ist die Seite gesperrt.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-nachlesen.html